ONEMA-POP-065 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Manejo e Orientação Domiciliar na Doença do Refluxo

Gastroesofágico e Prevenção de Broncoaspiração

1. Identificação institucional

ONEMA-POP-065 | Manejo e Orientação Domiciliar na Doença do Refluxo Gastroesofágico e Prevenção de

neste lote.

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de manejo e orientação domiciliar na doença do refluxo

gastroesofágico e prevenção de broncoaspiração, em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade.

Não substitui prescrição, avaliação médica nem instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

Roteiro alimentar, lista de medicamentos, avaliação de deglutição e risco de aspiração. Equipamentos profissionais/EPIs:

enfermeiro ONEMA; consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste contratual. Em visita presencial,

equipamentos de avaliação clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

Pirose/regurgitação, disfagia, tosse após refeições, perda de peso, sangramento e sintomas respiratórios. Confirmar

identificação, consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Identificar frequência, gatilhos, horários, posição após refeições e medicamentos em uso.

02. Pesquisar disfagia progressiva, odinofagia, perda ponderal, hematêmese, melena e dor torácica.

03. Na dor torácica sugestiva de causa cardíaca, não atribuir ao refluxo; acionar urgência.

04. Orientar medidas individualizadas: evitar deitar logo após comer, refeições menores e elevação da cabeceira quando

apropriado.

05. Se tosse, engasgos ou voz molhada após deglutição, suspender oferta oral insegura e solicitar avaliação de deglutição.

06. Não prescrever supressores de ácido ou modificar terapia sem prescrição e avaliação apropriada.

07. Definir acompanhamento médico e avaliação especializada diante de sintomas de alarme ou refratariedade.

08. Registrar sintomas, fatores, sinais de aspiração, orientações e encaminhamento.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Disfagia importante, aspiração com desconforto respiratório, sangramento ou dor torácica: urgência. Na emergência, acionar

SAMU 192 e registrar o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar prevenção de broncoaspiração e retorno se sintomas persistirem.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento,

orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

ACG Clinical Guideline GERD 2022; NICE CG184 Gastro-oesophageal reflux disease and dyspepsia | Conferir aplicação

integral ao cenário brasileiro e IFU específico antes de liberação assistencial.

aplicativo.